

26 - 04- Les Syndromes hémorragiques du nouveau-né - Pr. N. El Idrissi Slitine

Les syndromes hémorragiques du nouveau-né L'hémorragie à la période néonatale est une pathologie fréquente et grave du fait du risque neurologique qu'elle engendre. La démarche diagnostique est principalement clinique aidée par la biologie. La maladie hémorragique du nouveau-né est la plus importante à connaître, d'ailleurs la plus fréquente.

Une simple prophylaxie, qui est très peu coûteuse, obligatoire et systématique, peut sauver la vie du nouveau-né. Quelle est la conduite à tenir devant un syndrome hémorragique ? Les antécédents familiaux similaires sont très importants à connaître. Il faut connaître le déroulement de la grossesse.

Si la maman a pris des médicaments durant la grossesse, quels types de médicaments ? S'il y a des facteurs de risque infectieux, quels ont été les modalités d'accouchement ? Voix basse, césarienne, administration de la vitamine K en salle d'accouchement, mode d'alimentation. Le nouveau-né a-t-il été sous arrêt martifciel, sous arrêt maternel exclusif ? Et puis, la caractéristique de ce syndrome hémorragique. Quel type d'hémorragie ? Extériorisée, non extériorisée ? Quel siège ? Est-ce que c'est des hémorragies très importantes ? Ou est-ce que c'est cutanée ? Est-ce que c'est ombilical ? Est-ce que c'est sous forme d'hématome ? A l'examen clinique, on appréciera le plus souvent et le plus urgent possible le retentissement du syndrome hémorragique.

Donc, premier réflexe, c'est de voir l'état hémodynamique, à savoir la fréquence cardiaque au temps de recoloration de la tension artérielle. Ensuite, l'état neurologique. On appréciera donc la conscience, s'il existe des signes de localisation.

Le périmètre crânien, il faut le mesurer, voir s'il est augmenté ou normal. Et puis, on doit apprécier si ce nouveau-né a une mobilisation douloureuse de la tête. C'est important aussi de voir, est-ce que ce bébé présente un syndrome anémique ? Les caractéristiques du syndrome hémorragique sont très importantes.

D'abord, est-ce que ce sont des signes hémorragiques extériorisés ? Ou ce sont plutôt des signes d'hémorragie interne ? Les signes hémorragiques extériorisés sont très faciles à connaître. On peut avoir un purpura, une églésie chimose, des hématomes superficiels, une hématomèse, rectoragie, méléna, des saignements au point de contact, tout ça on peut le voir à l'œil. Ce qui est le plus difficile cependant, ce sont les hémorragies internes.

D'ailleurs, ce sont les plus graves, car elles peuvent passer inaperçues. Les hémorragies internes, telles que l'hématome capsulaire du front, de la rate, l'hématome sidurale, l'encéphale hématome, l'hémorragie digestive qui est non extériorisée. Là, il faut redouter l'existence d'hématomes profonds à chaque fois qu'on a un syndrome hémorragique.

Un réflexe à avoir, c'est de rechercher systématiquement si on a un état de choc avec Bala. Parce que l'hémorragie peut être encore plus grave et elle peut être profonde et occulte. Très important aussi de voir quels sont les signes associés à ces hémorragies.

Est-ce qu'il y a des signes infectieux ? Est-ce qu'il y a des lésions infectieuses ? Est-ce qu'il y a des signes cutanés, à savoir l'eczéma non germes, qui peuvent nous orienter vers certaines étiologies ? Le bilan biologique doit être rapide, ne doit souffrir d'aucun retard. La clinique est assez évidente et donc il ne faut qu'à savoir, reconnaître, quel type de syndrome hémorragique c'est. C'est le bilan biologique qui va conduire à ce diagnostic étiologique.

Le bilan de coagulation avec un TP, un TCA et un hémogramme, on recherchera surtout l'annulation plaquettaire. Plus ou moins, on va faire un temps de saignement et on dosera des produits de dégradation de la fibrine. En fonction des situations, on fera un bilan infectieux et on pourrait faire une exploration abdominale, neurones, radiologiques.

On cherche des facteurs reprouvés. Deux catégories dans les étiologies. Les troubles de coagulation et la deuxième catégorie, ce sont les troubles de l'hémostase primaire, à savoir la pathologie des plaquettes.

Les troubles de coagulation, première des choses à connaître, c'est la maladie hémorragique du nouveau-né. Il faut savoir qu'il y a des facteurs favorisants chez le nouveau-né exposé. Le nouveau-né exposé est exposé au déficit en vitamine K, car il y a un faible transfert placentaire de ces dernières, une insuffisance d'apport, une faible quantité dans les laits et puis, il y a une absence de synthèse endogène par le fœtus.

La clinique, il y a trois formes. La forme la plus classique et la plus fréquente, la plus connue, dite forme classique, qui survient entre le 2^{ème} et le 7^{ème} jour. Elle se caractérise par l'existence d'hémorragies digestives, d'hématomes extensifs du cuir chevelu avec parfois une anémie.

Puis, il y a la forme précoce qui survient dès les premières 24 heures de vie et qui est favorisée par la prise médicamenteuse de la maman, de médicaments à action anti-vitamine K, telles que les anti-épileptiques par exemple. Puis, il y a les formes graves qui sont tardives et qui surviennent après la 3^{ème} semaine, entre la 3^{ème} et la 8^{ème} semaine. Graves parce qu'elles sont provoquées d'hémorragies intracrâniennes.

Il y a des facteurs favorisants là aussi, l'absence de prise de vitamine K prophylactique, un allaitement maternel exclusif, une antibiothérapie à large spectre chez des nouveau-nés hospitalisés à longue durée, une alimentation parentérale non supplémentée, une cholestase et un syndrome de malabsorption. Dans cette maladie hémorragique du nouveau-né, il faut savoir les paramètres biologiques dans cette pathologie. Le TP est bas, le taux de fibrinogène est normal, le taux de plaquettes est normal.

Et puis, très important, une normalisation rapide du TP juste après l'administration de la vitamine

K. Cela fait le diagnostic positif de certitude de la maladie hémorragique du nouveau-né. Nous avons également les facteurs vitamine K dépendants qui sont diminués. Comme vous le savez, c'est le facteur 2, 7, 9 et 10.

Le traitement, là aussi, est très important, il est facile, il ne coûte pas cher. Le traitement curatif, on va administrer de la vitamine K à 3 mg par kg misélante. Et puis, on peut avoir recours au plasme frais congelé.

Puis, le traitement préventif, c'est le plus intéressant, parce qu'il permet d'éviter des catastrophes et donc d'éviter d'engager le pronostic vital de ces bébés par une simple administration de la vitamine K à raison de 1 à 2 mg en entraînement musculaire systématique à la naissance ou bien un apport oral de 1 à 2 mg par semaine de vitamine K pendant 5 semaines pour le nouveau-né nourri au sein exclusivement. Les nouvelles recommandations prennent seulement 3 doses actuellement qui doivent être systématiques de vitamine K à raison de 2 mg par dose pour un nouveau-né à terme. On donne la première dose à la naissance.

Pour mémoriser, on la donne à 4 heures. Puis, entre 72 et 96 heures pour mémoire, 4 jours. Et puis, la troisième dose va se donner à 1 mois pour mémoire, 4 semaines.

Donc, vous avez la règle de 4-4-4. En cas de sortie précoce après 48 heures de vie, la deuxième dose de vitamine K peut être même administrée avant la sortie. C'est juste pour garantir une bonne administration, une meilleure observance de la prise de la vitamine K. Après la maladie hémorragique du nouveau-né, vous avez aussi, chez le nouveau-né, la coagulopathie de consommation.

Elle est liée à une pathologie qui est grave. Soit des infections sévères, une anoxie aiguë, un état de collapsus, une hypothermie. Et le tableau clinique est également grave par des hémorragies diffuses, incontrôlables.

A la biologie, nous allons trouver des consommations des facteurs de coagulation, ainsi qu'une thrombopénie, une diminution du fibrinogène, une augmentation du produit de dégradation de la fibrine. La troisième des étiologies, c'est l'insuffisance hématocellulaire aiguë, qui peut être d'origine métabolique, infectieuse, auto-humaine ou toxique. Et là, dans l'insuffisance hématocellulaire aiguë, le facteur 5 est bas.

Le facteur 5 est un facteur non-vitamine-K-dépendant pour les membres. Puis, le déficit constitutionnel en facteurs de coagulation, à savoir l'hémophilie A ou B, ou la maladie de Wilbrand. Nous avons aussi le déficit en facteur 13, qu'on retrouve en période non-natale, pas fréquemment, mais qu'on retrouve la fibrinogénémie congénitale, qui se caractérise à la clinique par un saignement ombilical à la chute du cordon.

Et puis, les autres facteurs de coagulation peuvent être là-dedans. Un deuxième cas de figure, c'est les troubles de l'hémostase primaire, à savoir les plaquettes. Les plaquettes peuvent être

pathologiques par deux moyens, soit diminuant en nombre ou bien diminuant en qualité.

La thrombopénie est définie, en période non-natale, par un taux de plaquettes qui est inférieur à 100 000 par millimètre cube. Le syndrome hémorragique peut survenir une fois que les plaquettes sont inférieures à 50 000. Et le risque d'hémorragie cérébrale est très important en présence d'un taux de plaquettes inférieur à 20 000.

Donc c'est très important de connaître exactement le chiffre de plaquettes et de savoir à quel risque une monnaie est exposée à chaque fois que le taux de plaquettes est bas. Les thrombopénies d'origine infectieuse peuvent être bactériennes, à l'occasion d'une infection non-natale ou virale, parfois associée à une sémi-délie. Et puis, il y a des thrombopénies d'origine immunologique, qu'on ne détaillera pas.

Puis il y a les autres pathologies des thrombopénies, toxiques, elles peuvent être constitutionnelles, malformatives, à l'occasion d'un neuroblast, d'une leucémie, d'un aimant germe géant, etc. Les thrombopathies peuvent être congénitales, c'est la thrombastémie de Glanzmann, ou acquise, à l'occasion d'une prise médicamenteuse par la maman, de l'aspirine par exemple, ou chez le bébé, à l'occasion d'une alimentation parentale prolongée, où on a une carence en acide immunologique et en vitamine E. En pratique, devant un syndrome hémorragique du nouveau-né, on fait rapidement une anamnèse, la recherche d'antécédents, un examen clinique rapide, qui ne doit en aucun cas retarder la prise en charge quand le pronostic vital est mis en jeu. Donc, l'annumération et un bilan des coagulables le plus urgent possible.

Soit c'est une maladie hémorragique du nouveau-né, on est très content et on traite rapidement. Soit une thrombopénie, là aussi on doit absolument connaître le chiffre de la thrombopénie et les enjeux de cette thrombopénie, qu'est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce qu'on doit surveiller. Soit c'est une anomalie de l'hémostase, c'est une anomalie de coagulation, on est soit devant une CIVD, là le contexte est assez bruyant, ou alors on est devant une insuffisance hépatocellulaire, ou devant une maladie constitutionnelle.

Et ça, c'est quand même une étiologie qui est plus rare. Donc, en conclusion, il est très intéressant d'observer les mesures prophylactiques d'une façon drastique. La vitamine K doit être administrée afin de prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né, la maladie qui peut engager le pronostic vital.

Et puis la prise en charge doit être correcte s'il y a un risque thrombopénie d'origine immunologique. Je vous remercie.